Notiz an die Sektionsleitung: Sprachfassungen der SL-Limitierungen, Prüfung vom 6. Oktober 2026

Stand 11.10.2026. Entwurf; Adressat und Absender «durch BAG zu ergänzen». Der Antrag steht auf einer Seite in der Entscheidvorlage.

Worum es geht

Ein Programm hat alle 1688 Limitierungen der SL-Publikation vom 6. Oktober 2026 in DE, FR und IT verglichen: Zahlen, Sprache des Feldes, Tippfehler und Begriffe, die das BAG anderswo bereits korrigiert hat. Es liest nur die öffentliche Publikation und ruft kein Sprachmodell auf. Ergebnis: **38 Befunde** auf 27 Limitierungen, zusammengefasst in 18 Sachverhalten. Die Einstufung stammt von **blinden Claude-Annotatoren** (zwei, ein dritter bei Uneinigkeit), nicht vom BAG: **16 real** (die Bedeutung weicht ab), **12 geringfügig** (Form fehlerhaft, Bedeutung erhalten), **10 nicht bestätigt** (`eval/results/audit_relabel.json`).

Die Zahlen auf einen Blick (`eval/results/audit_grouping.json`, Abschnitt `reconciliation`; bestätigt = von der Mehrheit der blinden Annotatoren als real oder geringfügig eingestuft):

	Anzahl	bestätigt	real (Bedingung weicht ab)	geringfügig	nicht bestätigt
Befunde (Zahl, Einheit, Sprache, Tippfehler)	27	17	12	5	10
Terminologie-Hinweise	11	11	4	7	0
Total im Register	**38**	**28**	**16**	**12**	**10**
Experimentelle Prüfung (aus, separat geführt)	31	6	3	3	25

Im Register ergeben die 38 Befunde und Hinweise 18 Sachverhalte (Fälle), gruppiert nach der Einstufung der Annotatoren; die 4 Fälle, die sie nicht bestätigt haben (darunter die 3 vermutlich gleichwertigen Formulierungen), sind eingeklappt. Die Befunde der experimentellen Prüfung gehören nicht zu den 18 Fällen und werden im Register separat gezählt.

Abweichungen in der Bedeutung (real)

- **Nemluvio** (IT): Erhaltungsdosis DE alle acht Wochen, IT alle vier Wochen («ogni quattro settimane»).
- **Diaphin** (IT): preisbezogener Zuschlag DE 6 %, IT 12 %.
- **Cresemba** (FR): DE verlangt ein Körpergewicht von mindestens 16 kg; FR nennt keines.
- **Dupixent** (FR, 4 Limitierungen): DE 15 bis < 60 kg, FR 30 bis < 60 kg; in zwei weiteren fehlt in FR die Gewichtsklasse 15 bis < 30 kg. Zwei der vier Abweichungen erscheinen erstmals im Stand vom 1. Juni 2026.
- **Etanercept** (Benepali, Erelzi, Nepexto; FR): FR schränkt die juvenile Arthritis auf Patientinnen und Patienten ab 62,5 kg ein; DE nicht.
- Weitere: **Keytruda** (KN045): das IT-Feld enthält den französischen Text, seit dem Stand vom 1. August 2026. **Perindopril-Kombinationen** (4 Limitierungen, FR): «inhibiteur de l'enzyme de conversion» (ACE-Hemmer), wo eine andere Wirkstoffklasse gemeint ist (Angiotensin-II-Antagonist); das BAG hat die Wendung in anderen Limitierungen bereits ersetzt. **Forsteo** (IT): «almeno se mesi» statt «sei mesi».

Operator- und Negationsmodul (zuschaltbar)

Ein Zusatzmodul liest Vergleichsoperatoren, Verneinungen und Zahlwörter. Es liefert mehr Kandidaten als die Hauptprüfung und ist deshalb zuschaltbar. Von seinen 31 Befunden haben die Annotatoren 6 bestätigt, davon 3 real (`eval/results/audit_r15.json`):

- **Amvuttra** (FR): Abbruchkriterium DE «NIS-Zunahme > 10 Punkte», FR «≤ 10 points».
- **Beyonttra** und **Vyndaqel** (IT): «on deve essere combinato» statt «non deve»: aus dem Kombinationsverbot wird dem Wortlaut nach eine Pflicht.

Was Phase 1 kostet

Keine Beschaffung, keine Lizenz, kein Modell. Die 24 Fallblätter liegen vor (Übersicht). Aufwand gemäss adoption.md §4, Minutenwerte als *Annahme*: Prüfung der 38 Befunde rund 3–6 h einmalig; danach rund 1 neuer Befund pro Monat, unter 0,5 h; ein eigener Lauf im BAG rund 0,5 h.

Risiken

- Die Prüfung findet nicht alles; sie liefert eine Arbeitsliste, keine Bestätigung der Gleichwertigkeit.
- Die Einstufung ist nicht die des BAG; 10 der 38 Befunde haben die Annotatoren verworfen.

- Massgebende Sprachfassung und Korrekturweg einer publizierten Limitierung sind aus öffentlichen Quellen nicht bestimmbar; jedes Fallblatt verlangt sie aus dem Dossier.

Beantragter Entscheid

Freigabe von Phase 1 (Projektauftrag): Bezeichnung der Fachverantwortung und der Prüfenden, Prüfung und Visum der Fallblätter, Weiterleitung der Schutzbedarfsanalyse an die Informationssicherheit.